PEP UP 通信 #216

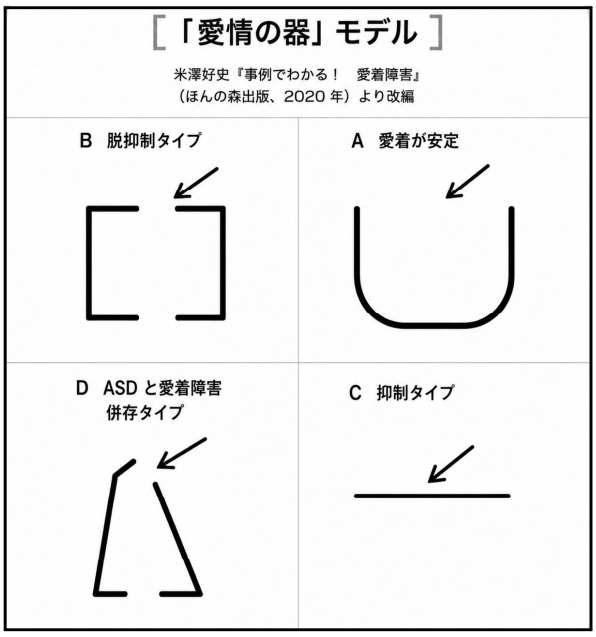
「愛情の器」モデルで愛着障害を捉え直す

工藤 功成

「愛情の器」モデルでは、愛着形成が進むとともに、子どもの中にかかわりを通して感じた愛情を、愛情エネルギーとしてためておく「器」がつくられる、と想定します。
きちんとした器があるから、子どもは「かかわり」として注がれる愛情を受け取り、それをためて行動の原動力に変えられる ――― そう捉えるわけです。

愛着が安定している子どもの中には、下のモデル図のAのような、きちんとした器ができます。
愛着障害とは、この受け止める器に何らかの不具合がある状態と考えることができます。

例えばBのように、**入り口が狭くて器の底に穴が開いていては愛情がたまりません。**
子どもは〈もっと、もっと！〉とさらなる愛情を大人に求めるでしょう。
脱抑制タイプの愛着障害はそのように捉えることができます。



また、Cのように、そもそも器が形成されていないと愛情を感じることができません。
これが抑制タイプを表現しており、まず器づくりから始めねばならないため、支援に時間がかかります。

穴に加えてDのように**入り口が狭く、蓋までついていると、支援には独特な困難がともなう**ことになります。
蓋が開いているときに、狭いストライクゾーンを狙って愛情を注がなければいけないからで、これがASD＋愛着障害タイプのイメージです。

ASD＋愛着障害タイプとは、ASD（自閉スペクトラム症）と愛着障害を併せ持った状態のことでした。
ASDがある子は認知に特異性があり、他の子にとっては快いかかわりを〈不快だ〉と感じることがあります。
つまり、「受け入れることのできるかかわり・刺激の幅が狭い」のです。
図Dの入り口の狭さはそのことをあらわしています。
加えて、まるで蓋をぴったり閉ざしたかのように、かかわりを頑なに拒絶し続けることもあります。
例えば、外部からのかかわりをシャットアウトしてしまった状態がそうです。
蓋が閉じてしまうと愛情は入っていきません。
そのことを絵的に表現しています。

以上のモデルを念頭に置くと、従来の支援がなぜうまくいかないかが見えてきます。
愛着障害は関係性の問題であり、感情発達の問題でもあります。
そこを意識しないと、「子どもがどう受け止めるか」が考慮されないまま、一方的なかかわりが行われることになりますが、そのような支援は不具合のある器に愛情を注ぎ続けるようなものです。

大事なのは、こちらがいくら愛情を注いでいるつもりでも、それを子どもが愛情と感じなければ愛情ではないということです。
愛着を愛情と勘違いするなとおっしゃる愛着の専門家がよくおられます。
愛着と注ぎ込む愛情は違う、というご意見ですが、**愛情を一方的に注ぐものだと捉えるのは間違いで、愛情はかかわりから子どもが感じるもの**です。
そして愛着の絆を通して子どもが愛情を感じ、関係性を意識して感情発達していくことを含めて「愛着形成」と捉えなければならないのです。

Aのように、器に不備がなければ、愛情は支援者の期待どおり、子どもの中に蓄積されていくでしょう。ところが、器に不備があり、愛情をためる準備ができていなかったら、どれだけ注ぎ込んでも素通りし、支援者の努力は徒労に終わります。
まずは子どもが、ポジティブな感情を感じ、それをためていけるように、器をつくるところからはじめなければなりません。
そして、器が十分できたところで、さらなる愛情を感じるかかわりを続け、愛着障害からの回復と自立を目指します。
そのような流れを意識した支援を行わなければいけないのです。